REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1078 del 03 agosto 2020

Oggetto: **Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente con infarto miocardico acuto (IMA) con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) sul territorio marchigiano.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcuni impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione dell'infarto miocardico acuto (IMA) con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) sul territorio marchigiano, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- *Deliberazione della Assemblea legislativa regionale n. 38 del 16/12/2011" Piano socio-sanitario regionale 2010/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo";*
- *DGR n.1345 del 30/9/2013 "Riordino delle reti cliniche della Regione Marche";*
- *DGR n.1219 del 27/10/2014 "Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 17/4/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR";*
- *DGR n. 1286 del 17/11/2014 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche";*
- *Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";*
- *DGR n. 541 del 15/07/2015 "Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (G.U. n. 127 del 4-6-2015);*
- *DGR n. 139 del 22/02/2016 "Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all´assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013";*
- *DGR n. 159 del 29/02/2016 "Provvedimenti di attuazione del DM 70/2015 concernente la riduzione dei posti letto ospedalieri, ai sensi dell´art. 1, comma 541 della L. 208/2015" ;*
- *DGR n. 1282 del 24/10/2016 "Legge nazionale 662/96, art. 1 comma 34 e 34 bis - Recepimento Intesa del 30 luglio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 146/CSR) e approvazione del "Progetto della Regione Marche", nell'ambito degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti nel PSN 2006-2008, in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso";*
- *DRG n. 1554 del 19/11/2018 'Documento tecnico di ricognizione dello stato di attuazione del D.M. 70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";*
- *DGR n. 1623 del 27/11/2018 'Modifiche alla DGR n. 1554/2018 "Documento tecnico di ricognizione dello stato di attuazione del D.M. 70/2015 avente ad oggetto 'Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";*
- *DGR n. 1695 del 10/12/2018 Integrazioni alla DGR n. 1282/16: "Legge nazionale 662/96, art. 1 comma 34 e 34 bis - Recepimento Intesa del 30 luglio 2015 tra il Governo,*

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 146/CSR) e approvazione del "Progetto della Regione Marche", nell'ambito degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti nel PSN 2006-2008, in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso".

Motivazioni ed esito dell'istruttoria:

Le malattie vascolari cardiache e cerebrali rappresentano, in Italia e in Europa, tra le maggiori criticità di sanità pubblica. In questo gruppo di malattie, rientrano le più frequenti patologie di origine aterosclerotica, in particolare le malattie ischemiche del cuore (infarto acuto del miocardio, sindrome coronarica acuta ed angina pectoris), le malattie cerebrovascolari (ictus ischemico ed emorragico) e le arteriopatie periferiche. Esse rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale e hanno anche un notevole impatto in termini di disabilità.

In particolare, per quanto riguarda la malattia ischemica cardiaca, i documenti di consenso delle Società scientifiche e la Società Europea di Cardiologia (ESC) sottolineano come, per la gestione ottimale del paziente con infarto miocardico acuto (IMA), sia necessario un modello organizzativo coordinato di assistenza territoriale in rete. Nonostante i dati incoraggianti sulla riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari (CVD), in quasi tutti i Paesi Europei, le CVD sono causa del 45% di tutte le morti in Europa (3.9 milioni di morti) e del 37% delle morti negli Stati dell'Unione Europea (1.8 milioni di morti). Tra tutte le malattie cardiovascolari, la cardiopatia ischemica (IHD) rappresenta circa il 50% delle morti nei maschi e il 40 % delle morti nelle femmine.

In Italia, ogni anno, se ne verificano all'incirca 120.000, di cui una buona parte letale. Oggi la mortalità per attacco di cuore si assesta intorno all'11%, ma si ritiene che, nel giro di alcuni anni, questa percentuale si possa dimezzare, grazie a migliori strategie di diagnosi, terapia e prevenzione.

Per quanto riguarda la nostra Regione, analizzando le schede di Dimissione ospedaliera per Infarto del miocardio, è emerso che il numero dei casi di infarto miocardico acuto e di STEMI si è ridotto dal 2017 al 2018. Poco più della metà degli infarti sono di tipo NSTEMI, mentre gli STEMI sono circa il 37-39% e gli infarti a sede non specificata sono meno del 10% del totale.

Secondo quanto sancito nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, che fornisce la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, l'infarto miocardico acuto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI), rappresenta un'emergenza nell'ambito delle patologie complesse tempo-dipendenti. La rete per l'infarto miocardico acuto (IMA) rappresenta, pertanto, l'attuale standard di cura per lo STEMI.

Nella regione Marche, la rete cardiologica per il percorso STEMI è supportata dalla rete territoriale dell'emergenza-urgenza, caratterizzata da Postazioni Territoriale per l'Emergenza Sanitaria (PoTES). Il modello organizzativo adottato nella Regione Marche è quello di una rete di intervento territoriale che integra il Sistema di Emergenza Territoriale (SET) 118 con ospedali a diversa complessità assistenziale, organizzati secondo il modello di tipo hub & spoke. L'intera rete assistenziale ha lo scopo di garantire, a tutti i pazienti con STEMI, pari opportunità di accesso alle procedure salvavita di riperfusione coronarica, adottando strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate. In considerazione del profilo di rischio del paziente e delle risorse strutturali e logistiche disponibili, la presa in carico avviene tramite servizi ed ospedali con funzioni differenziate per livelli di competenza e risorse, valorizzando

l'importanza e la “pari dignità” di ogni ruolo e di ogni intervento.
Inoltre, la Regione Marche, con DGR 1282/16 e s.m.i., ha approvato il progetto "Rete Telematica per la Gestione delle Sindromi Coronariche Acute della Regione Marche", nell’ambito degli Obiettivi del PSN 2006-2008, in tema di assistenza sanitaria nelle isole minori e località disagiate, che prevede la strutturazione, su scala regionale, del sistema di teleconsulto ECG nell’emergenza-urgenza cardiologica (percorso IMA STEMI).
All’inizio del 2018, è stato costituito il Gruppo di Esperti per la definizione del PDTA Regionale sull’Infarto Miocardico Acuto con ST sopra-slivellato, sulla base dei nominativi forniti dagli Enti del SSR, rappresentativi dell’intero percorso di presa in carico del paziente durante la fase acuta. Tale gruppo, composto dai responsabili delle strutture organizzative coinvolte nella gestione di questi pazienti, è stato affiancato da un team di supporto metodologico che ha fornito gli strumenti per il buon funzionamento del gruppo. Il documento prodotto, Allegato A alla presente deliberazione, descrive il percorso operativo e clinico assistenziale per la gestione del paziente con infarto miocardico acuto (IMA) con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI). L'obiettivo del PDTA regionale è quello di definire le modalità operative della rete regionale Cardiologica nella gestione dello STEMI, stabilendone le caratteristiche qualitative e quantitative, al fine di garantire il migliore trattamento del paziente su tutto il territorio regionale e risolvere eventuali criticità nel percorso assistenziale, in particolare nella fase acuta.
I principali obiettivi del PDTA per la gestione dell’infarto miocardico acuto (IMA) con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) possono essere così riassunti:

- garantire l’equità di accesso per una tempestiva ed efficace rivascolarizzazione, sia questa l’angioplastica primaria che la trombolisi, al maggior numero di pazienti della Regione Marche affetti da STEMI;
- assicurare il trattamento interventistico con angioplastica al maggior numero di pazienti, in particolare a quelli con shock cardiogeno e quelli a più alto rischio ed ai pazienti con controindicazioni alla trombolisi;
- ottimizzare la diagnosi precoce favorendo lo sviluppo professionale di équipe esperte e competenti e all’utilizzo ottimale dei sistemi di teletrasmissione elettrocardiografica a distanza;
- migliorare la prognosi dei pazienti con IMA;
- razionalizzare l'impiego delle risorse.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in attuazione delle disposizioni di programmazione sanitaria regionale, al fine di permettere una maggiore equità e qualità della presa in carico dei pazienti sul territorio regionale, con la presente deliberazione si intende approvare il PDTA per la gestione del paziente con infarto miocardico acuto (IMA) con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI), definendo, contestualmente, linee operative e clinico assistenziali a garanzia dell'attivazione e funzionamento del PDTA medesimo presso gli Enti del SSR, secondo criteri omogenei del modello organizzativo proposto, senza comportare ulteriori oneri a carico degli Enti.
Sarà compito della Regione procedere, a seguito dell’adozione del suddetto PDTA sul territorio regionale, al monitoraggio della sua implementazione mediante appositi audit.

Per tutto quanto sopra si propone alla Giunta l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6

e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(*Dominga Cardascia)*

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA-URGENZA, RICERCA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(*Giovanni Lagalla)*

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
¬Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 24111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014

Il dirigente del servizio
(*Rodolfo Pasquini*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
allegato A IMAdomi_Mod .pdf - 5B4F003BCB705E343994511C1F01A7E6450AB55A283549C52A2943F950CD51BE
1078.pdf - 574B61FDE761B0C0A20B964772AF8EDBAE6BE9A5A55B4E8428735AF53F414FD5